Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel

Rua Onésimo Laureano, 75 - Bairro: Centro - CEP: 97304032 - Fone: 559997-4663 - Email: frsaogabr2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002726-64.2024.8.21.0031/RS

AUTOR: LUCIANE DOS SANTOS MIRANDA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

RÉU: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV

SENTENÇA

Vistos.

I - RELATÓRIO

LUCIANE DOS SANTOS MIRANDA ajuizou ação de obrigação de fazer em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE**, postulando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda). Aduziu, em síntese, que é funcionária pública estadual, segurada do plano IPE Saúde, e que foi diagnosticada com Neoplasia de Mama Triplo Negativo, localmente avançada, Estágio IIIA (CID C50.9), com alto risco de morte. Narrou que seu médico prescreveu tratamento quimioterápico associado ao medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) 200mg, a ser aplicado a cada 21 (vinte e um) dias, por 17 (dezessete) ciclos, como terapia de intenção curativa, porém o plano de saúde negou a cobertura do fármaco em 22/04/2024. Sustentou que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento, cujo valor total é de R$ 1.006.145,00 (um milhão, seis mil, cento e quarenta e cinco reais). Pugnou pelo benefício da gratuidade da justiça. Formulou pedido de tutela de urgência. Requereu a procedência do pedido, para condenar a parte ré ao custeio integral do tratamento. Juntou documentos (evento 1, DOC1).

Deferido o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, recebida a petição inicial e deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte ré fornecesse o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) 200mg (evento 3, DOC1).

Citado (Evento 27), o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde apresentou contestação (evento 33, DOC1), arguindo, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo para que conste somente o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde. No mérito, defendeu a legalidade da negativa de cobertura, visto que o tratamento postulado não consta no rol de procedimentos do instituto, o qual é regido por legislação estadual específica (Lei Complementar nº 15.145/2018) e não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Discorreu sobre a natureza de autogestão do plano, a necessidade de observância do princípio da legalidade e da prévia fonte de custeio, bem como a importância da sustentabilidade do Fundo de Assistência à Saúde (FAS). Sustentou que existem tratamentos alternativos previstos em seus protocolos para a patologia da autora. Postulou o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência do pedido formulado pela parte autora. Acostou documentos.

Houve réplica (evento 33, DOC1).

Instadas sobre o interesse na dilação probatória (evento 40, DOC1), a parte autora informou que não possuía outras provas a produzir (evento 45, DOC1) e a autarquia demandada postulou o julgamento do processo (evento 56, DOC1).

Concedida vista dos autos ao Ministério Público (evento 59, DOC1).

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido (evento 62, DOC1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito tramitou regularmente com a observância de todas as formalidades legais, estando isento de vícios.

Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, haja vista que as partes não manifestaram interesse na produção de provas (evento 45, DOC1 e evento 56, DOC1).

Não foram aventadas pelas partes, assim como não verifico, de ofício, nenhuma questão preliminar, prejudicial ou nulidade a ser decretada.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a parte autora, diagnosticada com Neoplasia de Mama Triplo Negativo (CID C50.9), busca o custeio do medicamento oncológico Pembrolizumabe (Keytruda) por parte da autarquia demandada.

A parte ré, por sua vez, defendeu que o tratamento postulado não possui cobertura, por não estar previsto em suas tabelas e regulamentos, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente.

O pedido da parte autora merece prosperar.

O Sistema IPE Saúde, reorganizado pela Lei Complementar Estadual nº 15.145/2018, consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, conforme o art. 4º da referida lei.

De acordo com o art. 4º, §1°, da Lei Complementar Estadual nº 15.145/2018, ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

Ressalto, no entanto, que a ausência de previsão expressa do tratamento nos regulamentos da autarquia não constitui, por si só, motivo suficiente para a recusa da cobertura, especialmente quando a necessidade do tratamento é devidamente comprovada por laudo médico.

Isso porque o plano de saúde público, embora regido por normas próprias, deve garantir as condições de saúde e sobrevivência dignas de seus segurados, não podendo a Administração Pública, por meio de ato normativo, restringir a finalidade precípua do plano, consubstanciada na promoção da saúde, devendo a interpretação de suas normas ser feita de modo a alcançar esse objetivo.

Na hipótese dos autos, o laudo médico é claro ao indicar a necessidade do tratamento com Pembrolizumabe (Keytruda) para a autora, portadora de neoplasia de mama triplo negativo, ressaltando o alto risco de morte e que o tratamento proposto, de intenção curativa, aumenta as taxas de resposta patológica completa e reduz o risco de recorrência em aproximadamente 37% (trinta e sete por cento) (evento 1, DOC8), de modo que a urgência e a imprescindibilidade do tratamento estão cabalmente demonstradas.

No mais, a negativa da autarquia demandada, amparada na ausência de cobertura regulamentar (evento 1, DOC8), mostra-se abusiva diante da expressa e fundamentada indicação médica, a qual não pode ser sobreposta por limitações administrativas que esvaziam o objeto principal do plano de assistência à saúde.

Reforço, no ponto, que o fato de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPE Saúde não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido, uma vez que o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, porém não pode limitar o tipo de tratamento alcançado para a respectiva cura ou melhora da condição do paciente.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é possível a mitigação excepcional da taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando houver expressa indicação médica para o tratamento a que se submete o paciente.

Nesse sentido, colaciono a ementa do REsp n. 1.992.247/RN:

> *PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. 1. **A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se, contudo, sua mitigação em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a ausência de tratamento eficaz listado e a necessidade do procedimento prescrito por profissional habilitado (EREsp 1.889.704/SP, Segunda Seção, DJe 3/8/2022)**. 2. Comprovada nos autos, pelas instâncias ordinárias, a urgência do quadro clínico da paciente e a indicação médica do procedimento, é ilegítima a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, sobretudo quando não há prova de tratamento alternativo eficaz. 3. A ausência de requerimento da parte ré para produção de prova pericial durante a instrução impossibilita a alegação de nulidade por insuficiência probatória, vedando-se o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Evidenciada a falha na prestação do serviço e os transtornos causados à parte autora, mantém-se a condenação por danos morais, cujo valor arbitrado revela-se proporcional e razoável. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 1.992.247/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025) Grifei.*

Não fosse isso, o TJ/RS firmou entendimento de que o IPE Saúde deve fornecer o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) a seus segurados, quando comprovada a necessidade de ministração do fármaco para tratamento da moléstia, consoante se infere dos seguintes julgados:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IPE-SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. SELIC. I. **Caso em exame: Apelação interposta em desfavor da decisão que julgou procedente o pedido para determinar ao IPE-Saúde o fornecimento do medicamento "Kaytruda (Pembrolizumabe)", como tratamento para o diagnóstico de neoplasia maligna de colo de útero, estágio IV**. II. Razões de Decidir: O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento de que o rol da ANS é irrelevante para a análise do dever de cobertura de medicamentos oncológicos. **O laudo médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da enfermidade da recorrida, bem como a urgência da sua disponibilização. O entendimento desta Corte é no sentido de que pareceres técnicos emitidos por profissionais que não avaliaram pessoalmente o paciente não podem se sobrepor ao laudo do médico assistente**. III. Tese de Julgamento: **O rol da ANS é irrelevante para a análise da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer**. A partir da entrada em vigor da EC nº 113/21, deve-se observar a incidência apenas da taxa SELIC para fins de correção dos valores. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50037995420238210145, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliane Garcia Nogueira, Julgado em: 15-04-2025) Grifei.*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. **TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMANDANTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER RENAL EM ESTÁGIO AVANÇADO. FORNECIMENTO DE ANTINEOPLÁSICO: PEMBROLIZUMABE E AXITINIBE**. DETERMINAÇÃO DE COBERTURA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Hipótese em que se discute a obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos oncológicos Pembrolizumabe e Axitinibe para segurado do IPÊ-Saúde que possui diagnóstico de Câncer Renal em estágio avançado, considerando a legislação aplicável e a natureza abrangente da assistência oncológica prestada pelo plano. 2.*

__Negativa da autarquia que se revela indevida, pois, uma vez que o plano de saúde oferece cobertura para tratamentos oncológicos, esta deve ser ampla e efetiva, conforme previsto na Resolução nº 21/79 e na Lei Complementar nº 15.145/18. A ausência de previsão específica do medicamento nos protocolos internos não constitui impedimento para a sua cobertura, sendo vedado ao plano de saúde restringir a escolha terapêutica realizada pelo médico responsável, mormente quando comprovada a necessidade e urgência por laudo fundamentado. Sentença mantida nesse ponto__. 3. Em demandas de saúde, com proveito econômico inestimável, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa do julgador, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, observando-se as peculiaridades do caso concreto, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o zelo empregado no patrocínio da causa. É descabida a fixação da verba honorária, com base em percentual incidente sobre o valor da causa, visto que o proveito econômico nesse tipo de demanda é inestimável e não serve de parâmetro para o arbitramento da sucumbência. Verba honorária redimensionada em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais. Precedentes. Sentença parcialmente reformada nesse ponto. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50023666020238210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-06-2025) Grifei.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IPE-SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. I. __Caso em exame: Agravo interno em apelação interposta em desfavor da decisão que julgou procedente o pedido para determinar ao IPE-Saúde o fornecimento do medicamento "Kaytruda (Pembrolizumabe)", como tratamento para o diagnóstico de neoplasia maligna de colo de útero, estágio IV__. II. Razões de Decidir: O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento de que o rol da ANS é irrelevante para a análise do dever de cobertura de medicamentos oncológicos. O laudo médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da enfermidade da recorrida, bem como a urgência da sua disponibilização. __O entendimento desta Corte é no sentido de que pareceres técnicos emitidos por profissionais que não avaliaram pessoalmente o paciente não podem se sobrepor ao laudo do médico assistente. III. Tese de Julgamento: O rol da ANS é irrelevante para a análise da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer__. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50037995420238210145, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliane Garcia Nogueira, Julgado em: 24-07-2025) Grifei.

Portanto, o pedido da parte autora merece prosperar, para condenar a parte ré a fornecer à requerente o tratamento com o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) indicado no laudo médico (evento 1, DOC9), confirmando-se a tutela de urgência deferida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na ação de obrigação de fazer proposta por **LUCIANE DOS SANTOS MIRANDA** em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL (IPE SAÚDE)**, para **CONDENAR** a parte ré a custear à requerente o tratamento oncológico com o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) 200mg, a cada 21 (vinte e um) dias, durante 17 (dezessete) aplicações, nos exatos termos da prescrição médica juntada aos autos (evento 1, DOC9), **confirmando a tutela de urgência deferida no evento 3, DOC1**.

Retifique-se o polo passivo no Sistema Eproc, para que conste como réu apenas o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande DO Sul (IPE Saúde).

Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais fixo por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, uma vez que a demanda diz respeito à preservação da vida e da saúde, na forma do Tema n° 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Isento o IPE Saúde do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I, da Lei nº 14.634/2014). Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014) exceto condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014- CGJ).

Caso a parte vencedora tenha antecipado taxa única e despesas, o ente público deverá reembolsar estes valores da seguinte forma (Lei n° 14.634/2014, art. 5º, parágrafo único, parte final):

a) com correção pelo IPCA-E (admitida a deflação, preservado o valor nominal, conforme o Tema n° 678 do STJ) a contar da data de cada desembolso;

b) com juros moratórios à taxa aplicada à caderneta de poupança (art. 12, inc. II, da Lei Federal n° 8.177/1991), a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, inc. II, do Código de Processo Civil, uma vez que o tratamento postulado pela parte autora supera o limite de 500 (quinhentos) salários mínimos nacionais.

Na hipótese de interposição de recursos voluntários pelas partes, cumprirá ao Cartório intimar a parte contrária para contrarrazões e, imediatamente após – apresentadas ou não as contrarrazões –, proceder à remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, independentemente de conclusão.

Não havendo recursos voluntários pelas partes, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado, para fins de remessa necessária, na forma do art. 496, § 3º, inc. II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CCalc para apuração de eventuais custas finais e despesas processuais.

Havendo custas e despesas processuais pendentes, encaminhe-se a guia à Central de Cobranças (CC). Saliento que, conforme o Ato nº 072/2022-P da Presidência, a cobrança das custas finais do processo será integralmente realizada pelo Departamento de Receita – Serviço de Cobrança, do Tribunal de Justiça, cabendo ao Cartório a comunicação ao aludido órgão acerca da pendência de custas, mediante remessa da guia à Central de Cobranças (CC).

Sentença publicada e registrada neste sistema.

Intimações eletrônicas expedidas no ato.

Oportunamente, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNA SOUZA SILVEIRA, Juíza Substituta**, em 15/01/2026, às 17:23:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10098360347v24** e o código CRC **a506fdcb**.